

Inducción, reinducción y entrenamiento supervisado

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Asegurar comprensión de riesgos, registros, limpieza, equipos y derechos antes de trabajar de forma autónoma.

2. Alcance y condiciones de uso

IPS: ingreso y reinducción del personal. Independiente: actualización y entrenamiento de apoyos y contratistas cuando existan. No se registra una inducción a personal inexistente.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Titular o dirección	Verificar autorización, vínculo y competencia antes de asignar.
Fisioterapeuta	Trabajar dentro de competencia, actualizarse y pedir apoyo.
Apoyo administrativo	Custodiar expediente laboral y no realizar intervención clínica.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Identificar el rol y sus tareas; seleccionar módulos de historia clínica, consentimiento,

Identificar el rol y sus tareas; seleccionar módulos de historia clínica, consentimiento, identificación, manos, limpieza, caídas, dispositivos, incidentes, emergencias y confidencialidad que apliquen.

2. Explicar la sede, rutas, ubicación de botiquín y extintor, puntos de residuos y medios de

Explicar la sede, rutas, ubicación de botiquín y extintor, puntos de residuos y medios de llamado. Recorrer las áreas y resolver dudas antes de iniciar atención.

3. Realizar demostración de equipos con el manual de marca y modelo

Realizar demostración de equipos con el manual de marca y modelo. Verificar conexión, accesorios, parámetros y apagado; evitar enseñanza exclusivamente verbal de equipos con riesgo.

4. Evaluar comprensión con preguntas y observación de tareas

Evaluar comprensión con preguntas y observación de tareas. Simular un error de identidad, un equipo dañado y una emergencia para comprobar la actuación prevista.

5. Documentar fecha, contenidos, duración real, participantes, evaluador, resultado y plan de

Documentar fecha, contenidos, duración real, participantes, evaluador, resultado y plan de refuerzo. Conservar las evidencias sin certificados de asistencia ficticios.

6. Programar reinducción ante cambio de equipo, protocolo, puesto, evento significativo o bre

Programar reinducción ante cambio de equipo, protocolo, puesto, evento significativo o brecha observada. Autorizar autonomía después de corregir el resultado insuficiente.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Entrenamiento previo a tareas nuevas.

Resultado práctico observado.

Cronograma local y refuerzo por hallazgo.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.1 y 11.3.1.1-5: talento humano, título y formación según oferta. Para integración neurosensorial, numeral 1.2 específico; verificar condiciones de la modalidad.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Persona y rol	
Fecha y actividad	
Contenido y versión	
Duración real	
Evaluator	
Prueba de conocimiento	
Demostración práctica	
Brecha detectada	
Refuerzo y plazo	
Resultado final	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576